

Fecha Última Actualización: 10-06-2022 18:44:15

Página 1 de 3

Información Paciente

Nombre : Fernando Duran Guajardo

Rut : 4.807.068-K

N° Archivo : 2110225

N° Epicrisis
307035

Edad : 76a 0m 10d

Fecha Nacto: 31/05/1946

Sexo : Masculino

Dirección : Nainco 2157 El Duraznal- Puente Alto

Comuna : Puente Alto

Teléfono : 2 2316 7695

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Utim

Fecha Ingreso : 05/05/2022 14:31

Días Estadía: 36

Unidad de Egreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Egreso : 10/06/2022 18:06

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Insuficiencia respiratoria

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

EPICRISIS

FI SU CASR: 06/05/2022

FI UTIM: 09/05/2022

FI UCI: 10/05/2022

ANTECEDENTES

· Médicos: DM2 NIR, HTA, Ca de pulmón células Pequeñas (2021 ,cT3N2M1, ECOG 1.)

· Quirúrgicos: (-)

· Fármacos: Metformina, Enalapril, ASA, Tramavolta (37,5/325 mg)

· Alergias: (-).

· Hábitos: Tabaco desde los 14 años hasta 42 años, 20 cig/día, IPA 28. . Alcohol (-), Drogas (-).

· Hospitalizaciones recientes: 18/06/2021-19/06/2021 Para estudio de Biopsia Bajo TAC

· Sociales: Casado, 1 hijo, vive con esposa en Puente Alto. Jubilado de conserje, trabajó en empresa de fundición y abrasivos (Cuarzo). FONO: 989098798 (pcte) / 223167695 (casa)

· Inmunizaciones (influenza, neumococo, covid): 4° dosis COVID19. + influenza.

ENFERMEDAD ACTUAL

Paciente con diagnostico desde 2021 de Ca de Células pequeñas que recibió tratamiento con Taxano y etoposido, además de Consolidación con RT torácica entre febrero y abril de 2022.

Posteriormente con diagnóstico de EPID sin diagnostico etiológico Obs actínica vs QT.

Evoluciona con disnea, baja de peso.

Consulta en ambulatorio en control con oncólogo tratante donde se encuentra en malas condiciones generales, con compromiso ventilatorio además de disnea aumentada, por esta razón se deriva al servicio de urgencia para estudio y manejo.

En el servicio de urgencia se estudia con Angiotac Examen sin signos de tromboembolismo pulmonar agudo hasta nivel segmentario.

- Progresión de cambios fibróticos pulmonares bilaterales.

- Opacidades parenquimatosas difusas con densidad en vidrio esmerilado. El diagnóstico diferencial debe incluir una etiología inflamatoria infecciosa versus parte de compromiso fibrótico pulmonar. Se sugiere controlar.

- Estabilidad en tamaño de lesión pulmonar subpleural en LID, compromiso adenopático mediastínico e hilar derecho y de la

Fecha Epicrisis : 10/06/2022 18:44

Página 1 de 3

Fecha Última Actualización: 10-06-2022 18:44:15

Página 2 de 3

lesión secundaria hepática posterior.

En ese contexto se hospitaliza para mayor estudio.

Desde su ingreso con alto requerimiento de Oxígeno, requiere CNAF con alto requerimiento de Flujo y Oxígeno.

El día de la fecha evoluciona con apremio ventilatorio, disnea y mala mecánica ventilatoria, se conversa con paciente, familiares y equipo tratante de oncología y se define manejo activo. Se decide IOT ARM posterior conexión a VMI, PEEP 8, Pr 24, Vt 370, FiO2 100%, SAT 97%. Se instala además CVC yugular izquierdo

Inicia sedación + analgesia.

En ese contexto se decide pase a UTI

Ingresa a UTI bajo efectos de sedoanalgesia SAS 1, pupilas mióticas isocóricas y reactivas, FIO 80%, con requerimiento de DVA 0.03 mcg/kg/min.

EXAMEN FÍSICO DE INGRESO UCI:

SAS 1 con sedación + analgesia

RR2TSS, MP (+) Se auscultan crépitos velcros bilaterales a predominio de bases.

Abdomen blando, depresible RHA (+).

Sin edema de extremidades inferiores

Sin signos de TVP, pulsos ++ simétricos.

DIAGNÓSTICOS DE INGRESO UCI:

· Insuficiencia respiratoria aguda sobre crónica

· EPID descompensada

· Etiología infecciosa vs EPID post actínica Vs RAM Taxanos

· Antecedentes: HTA, DM NIR, Ca De pulmón CCPP (2021, cT3N2M1, ECOG 1.)(MT hepáticas y Óseas)

EVOLUCION EN UCI

1. Hemodinamia: Macrohemodinamia inestable, con requerimientos de DVA, NAD que se titula al alza hasta 0.08 ug/kg/min. para PAM >65. Perfusion al limite. Lacta

2. Respiratorio: antecedente de EPID, sin estudio etiologico. Angiotac al ingreso sin TEP, con opacidades difusas en vidrio esmerilado, leve derrame pleural derecho y progresión de Fibrosis. Estuvo al inicio con CNAF pero por deterioro respiratorio se decide IOT y conexión a VMI el 10/5. Recibo pulsos de metil prednisolona (3/3) y ahora con prednisona de mantenimiento; hasta el momento, con mala respuesta a corticoides. El 18/05 por GSA de control (PM) con PAFI 131, se decide pronar a paciente completando 3 días hasta el 21/05. Posteriormente paciente con hipoxemia refractaria sin mejoría dependiente de VMI, con pocas posibilidades de destete por lo que se TQT el 30/05/2021, con evolución estacionaria sin progresar en weaning con requirimeinto altos de Fio2 manteniendo siempre > a 50%.

3. Infeccioso: Ingresa por cuadro de IRA con parametros inflamatorios elevados, con historia de disnea progresiva, y AngioTC de ingreso (-) para TEP, se pan cultiva y se decide manejo como NAC grave iniciandose tto empirico con Ampicilina Sulbactam/Azitromicina (FI 06/05) que se mantuvo hasta el 15/05, por no hallazgo de foco infeccioso.

- Del estudio infeccioso: Panel de Covid/FLU A/B (-), UC (-) HCs (-). LBA (11/05): Panel resp Molecular (-), PCR Mic TB (-), BK (-), PCR PCP (-), PCR CMV (-), Galactomanano (N). Pendientes rescatar: Cultivo TB, Cultivo de hongos, cultivo de Nocardia.

El 11/05 inicia pulsos de metilprednisolona 500 mg al día, ya completados (3/3), con prednisona mantenimiento. Con profilaxis con Cotrimoxazol tri semanal. Tac de torax de control del 17/05 con progresión en la cuantía del derrame pleural derecho e izquierdo. Opacidades parenquimatosas con densidad vidrio esmerilado bilaterales de distribución difusa, sin cambios. Focos de condensación con componente atelectásico en lóbulo inferior derecho y algunas escasas opacidades parenquimatosas de relleno alveolar basales izquierdas de posible etiología inflamatoria-infecciosa.

Por PI al alza con aumento de secreciones bronquiales purulentas, el 18/05 se solicita CAET y se inicia Imipenem empirico; se rescata resultado de CAET: Ps. Aeruginosa MS, se mantiene Imipenem x 5 días y se rota a ceftazidima hasta completar esquema. Pero persiste en el tiempo con cultivos de control el 04/06/2022 con PSA ahora Resistente a carbapenémicos por lo que nuevamente recibe esquema x 14 días de ceftazidima sin mucha repuesta. Actualmente sin manejo ATB.

4. Gastro: Paciente el 17/05 cursa con deposiciones liquidas aumentadas en volumen, se suspende PEG, conducta expectante, si nuevas deposiciones solicitar Toxina CD, en contexto de paciente con uso reciente de ATB de amplio espectro y aumento de PI. Sin cursar con conflicto.

Fecha Epicrisis : 10/06/2022 18:44

Página 2 de 3

5. Reumatológico: Se amplía estudio de EPID: Ac CPP (-). FR 32.9. ANA (-), ANCA (-), Anti DNA (-), Perfil ENA (-).
6. Renal/Medio Interno: Función renal estable sin presencia de alteraciones Hidroelectrolíticas. Privilegiar BH neutro a negativo.
6. Oncológico: Paciente 75 años antecedentes de EPID no Estudiada sin estudio etiológico ni funcional, que se pesquiza en Jun 2021 en TC Tx como estudio inicial de Ca Pulmonar (Cáncer Pulmonar cT3N2M1 en ECOG 1, células pequeñas), imagen con reticulaciones periféricas de discreta cuantía. Completa tto Oncológico Qt (con Taxano) + Etopósido + Rt consolidación torácica (Febrero y Abril 2022); ingresado actualmente por insuficiencia respiratoria aguda, angiotac de ingreso con progresión de fibrosis, obs progresión de EPID por RD reciente. Evaluado a su ingreso por oncólogo y dada la respuesta a tratamiento sin evidencia de progresión oncológica se determina manejo activo del paciente. Paciente al momento con nula respuesta al tto entregado, por el momento no innovar, en UCI trial.

Paciente grave, con mal pronóstico oncológico, persistencia de foco infecciosos pulmonar, con hipoxemia crónica refractaria con muy mala respuesta al manejo dado estacionario, sin poder progresar en destete de VMI, se define limitar esfuerzo terapéutico. Se da inicio a bic de morfina 5 mg/h. Familiares al tanto de condición clínica.

Hoy asistolia en monitor se constata fallecimiento a las 18: 10 horas y se informa a familiares. Se procede a certificado de defunción.

Diagnóstico de Egreso

Insuficiencia Respiratoria aguda - Ca pulmón + EPID
Neumonía x PSA Resistente a carbapenémicos persistente

Condición de Egreso

Fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

Hora de muerte 18:10 horas

Plan Post Alta

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

INTERNO



Bec. Kathleen Mariel Carpio Leon

Becado/Residente



John Gutierrez Gonzalez

Médico Tratante (Staff)